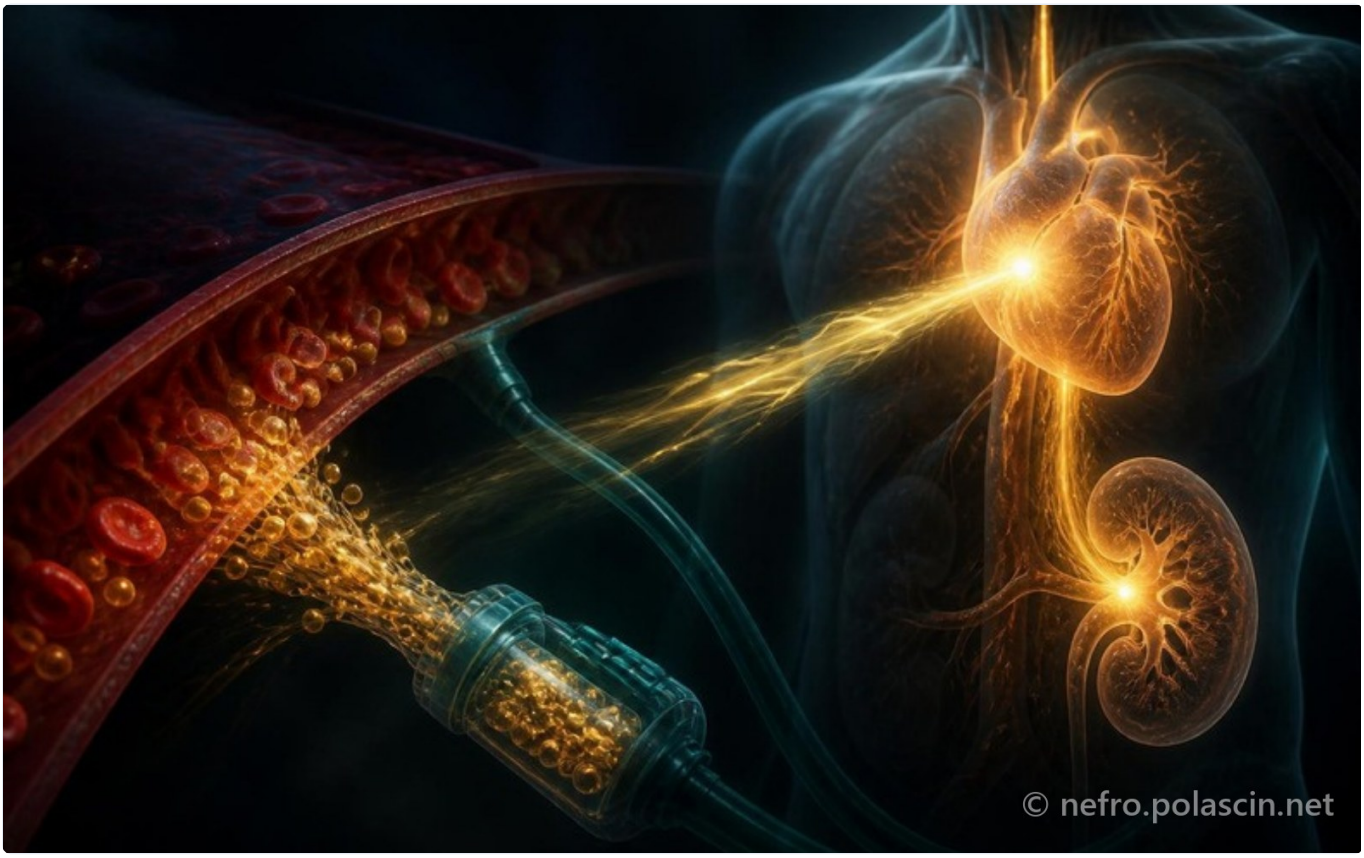
Kazuisticky: Ako zvládnuť hyperkaliémiu pri CKD a srdcovom zlyhávaní tak, aby sme neznižovali účinnú liečbu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Draslík sa dá riešiť samostatne – účinnú liečbu tak nie je nutné oslabiť.

V praxi narážame stále na ten istý problém: pacient má chronickú chorobu obličiek a zároveň srdcové zlyhávanie, je kandidátom na inhibíciu RAAS (ACEi/ARB) a často aj na MRA (napr. spironolaktón). Hyperkaliémia však vyvoláva obavy, lekári liečbu obmedzujú alebo prerušujú a pacient tak prichádza o liečbu, ktorá zlepšuje prognózu.

Tento článok vychádza zo vzdelávacej aktivity „Case-Based Approach: Managing Hyperkalemia in Patients With CKD and Heart Failure“ a jej hlavné myšlienky prenáša do praktického kazuistického rámca.[1]

Kazuistika na začiatok: 45-ročná žena s CKD 3b a HFrEF (NYHA II)

Aktivita začína prípadom 45-ročnej ženy s CKD 3b, eGFR < 40 ml/min, proteinúriou a súbežným srdcovým zlyhávaním NYHA II. Pacientka prichádza s veľkou obavou: „Mám CKD aj srdce. A keď mi stúpne draslík, čo potom?“

Podstatou kazuistiky je, že obava z hyperkaliémie vedie k nedostatočnej liečbe. Aktivita zdôrazňuje, že inhibítory RAAS sú základom znižovania kardiorenálneho rizika, no hyperkaliémia často bráni ich optimálnemu nasadeniu či udržaniu.[1]

Kľúčová zmena v uvažovaní: hyperkaliémia nemá automaticky zastaviť inhibíciu RAAS

Podľa aktivity odporúčania KDIGO 2024 jasne hovoria, že hyperkaliémia by sama osebe nemala byť dôvodom na ukončenie inhibície RAAS. Logika je jednoduchá a klinicky dôležitá:

1. **GDMT (guideline-directed medical therapy) zlepšuje morbiditu aj mortalitu**,

2. **hyperkaliémiu treba riešiť aktívne**, nie ústupom zo základnej kardioprotektívnej liečby,
3. praktický postup je **udržať RAAS/MRA** a k tomu pridať **liečbu viažucu draslík** (a tam, kde to má zmysel, aj diuretiká na podporu exkrécie draslíka).[1]

Hyperkaliémia tak prestáva byť „dôvodom liečbu zastaviť“ a stáva sa „dôvodom doplniť správny nástroj“.

Problémom je aj poddiagnostikovanie a nedostatočná eskalácia liečby

Jedným z hlavných argumentov aktivity opretých o dáta je register CARE-HK v populácii s HFrEF a často pokročilejšou CKD (napr. CKD 3b, eGFR < 40). Kazuistická časť z neho vyvodzuje, že:

- **RAASi alebo MRA neboli adekvátne využité u zhruba jednej tretiny** pacientov,
- **obavy z hyperkaliémie** sú podľa autorov hlavným dôvodom,
- hyperkaliemické epizódy sa ukazujú ako **rekurentné** a zároveň sa pozoruje **nízke používanie liekov viažucich draslík**,
- s poklesom funkcie obličiek ďalej klesá optimalizácia GDMT a v pokročilých štádiách je podiel pacientov na odporúčanej liečbe alarmujúco nízky.[1]

Záver kazuistiky je teda dvojaký: nejde len o to, čo urobiť pri jednej epizóde, ale aj o to, ako zabrániť, aby sa pacient dostal do začarovaného kruhu nedostatočnej liečby.

Lieky viažuce draslík: mechanizmy nie sú rovnaké, preto sa líšia aj bezpečnostné signály

Aktivita prakticky porovnáva dve moderné látky viažuce draslík: **patiromer** a **sodium zirconium cyclosilicate (SZC)**.

Rozdiel v mechanizme a jeho možný klinický význam

- **Patiromer**: výmena draslíka za vápnik (calcium–potassium exchange).
- **SZC**: výmena draslíka za sodík (sodium–potassium exchange). V aktivite sa uvádza, že pri porovnateľných dávkach môže byť sodíkové zaťaženie klinicky relevantnou protihodnotou.[1]

Z toho vyplýva klinicky relevantná otázka: ak SZC prináša viac sodíka, môže to u niektorých pacientov zhoršiť retenciu tekutín a vyvolať alebo zhoršiť srdcové zlyhávanie.

Bezpečnostné signály pre SZC (edém, zhoršenie HF)

Aktivita uvádza, že v menších randomizovaných štúdiách aj v súhrnných (pooled) analýzach sa pri SZC v populácii s neobjasneným alebo už prítomným HF objavoval signál pre zhoršenie srdcového zlyhávania a edémové udalosti, čo sa premietlo aj do regulačných aktualizácií.[1]

Údaje zo štúdií: REALIZE-K (SZC) vs. DIAMOND (patiromer)

REALIZE-K (SZC) pri spironolaktóne

V štúdii REALIZE-K sa SZC používal u pacientov, ktorí mali pokračovať v liečbe spironolaktónom napriek riziku hyperkaliémie. Aktivita zdôrazňuje, že sa pozorovali bezpečnostné udalosti spojené so srdcovým zlyhávaním a ich dôsledkom bol vyšší počet závažných nežiaducich príhod (serious adverse events) pre srdcové zlyhávanie.[1]

DIAMOND (patiromer) a natriuretický profil

Na porovnanie sa uvádza štúdia DIAMOND: pri patiromeri sa v subanalýze zaznamenal postupný pokles NT-proBNP, ktorý zodpovedá očakávanému účinku dobre vedenej neurohormonálnej liečby u pacientov s HFrEF.[1]

Praktický význam: ak pacient potrebuje MRA aj inhibítor RAAS, výber lieku viažuceho draslík môže ovplyvniť nielen draslík, ale aj kardiovaskulárnu toleranciu a bezpečnosť.

Čo si odniesť do praxe

- **RAAS blokádu neukončovať len kvôli hyperkaliémii**, ak sa dá pokračovať s podporou liečby viažucej draslík.[1]
- **Obavy z hyperkaliémie prekonať** správnou liečbou a monitorovaním, aby pacient GDMT skutočne dostal a udržal.
- **Multidisciplinárna spolupráca** (kardiológ, nefrológ, internista) je pri výbere vhodného lieku viažuceho draslík kľúčová, lebo bezpečnostné signály a mechanizmy nie sú rovnaké.

Zdroj: *Medtelligence CE na ReachMD, „Case-Based Approach: Managing Hyperkalemia in Patients With CKD and Heart Failure“. Zdroj aktivity.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kazuistika-hyperkaliemia-ckd-hf-zachovanie-raas · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.